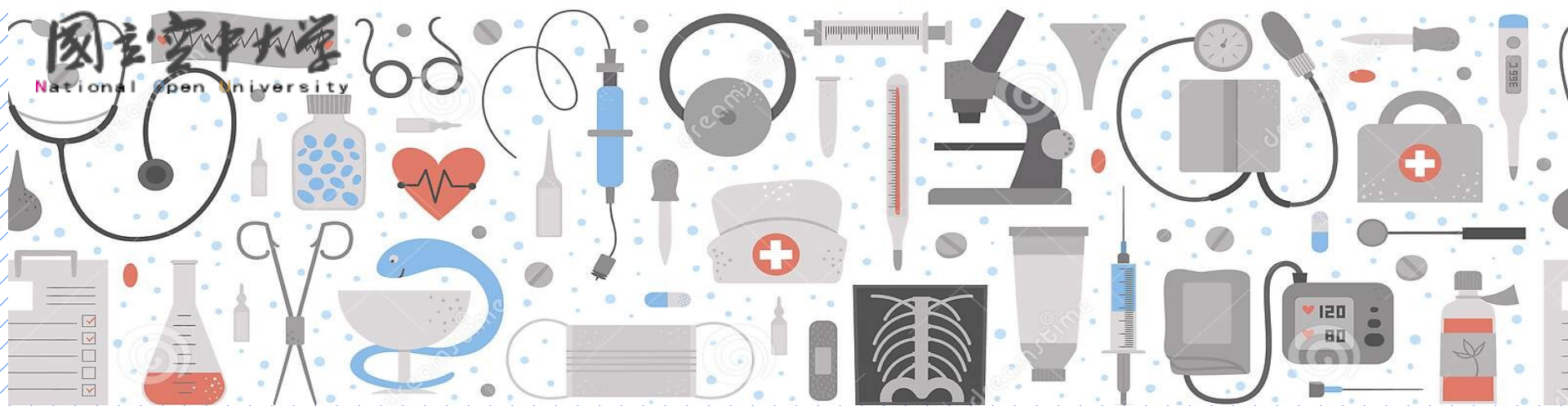




健保永續之挑戰



衛生福利部中央健康保險署 陳亮妤署長

114.10.07 國立空中大學演講

陳亮妤署長 M.D., PhD

獲獎與榮譽

臺灣成癮醫學卓越成就獎，2024
國立成功大學醫學系優良校友，2023
臺北市醫師公會杏林獎，2022
科技部優秀年輕學者計畫得主，2019-2021
行政院全國反毒有功人士，2020
美國國家藥物濫用署正式會員，2017-
臺灣成癮科學會年度最佳論文獎，2015
第五屆亞洲精神醫學會 Sartorius 獎，2014
約翰霍普金斯 Phi Beta Kappa 榮譽學會會員，2014
約翰霍普金斯 Lucy Shum 精神醫學貢獻獎，2014
約翰霍普金斯 Sommer 獎學金，2012-2014
美國國家藥物濫用署性別差異研究獎，2012

公共服務

中央健保署副署長 2024-2025
衛生福利部心理健康司司長 2023-2024
臺灣精神醫學會秘書長 2021-2023
衛生福利部精神疾病防治諮議會委員 2021-2023
臺北市防疫委員 2021-2023
臺灣成癮醫學會理事 2020-2023
衛生福利部管制藥品委員會委員 2019-2023
臺灣成癮醫學會秘書長 2018-2020
宜蘭毒品危害防制諮議委員 2019-2023
新北市心理衛生諮議委員 2018-2020



學歷：

美國約翰霍普金斯公共衛生博士
國立成功大學醫學系

報告大綱



1

超高齡社會 健保挑戰

2

888 計畫 強化慢病

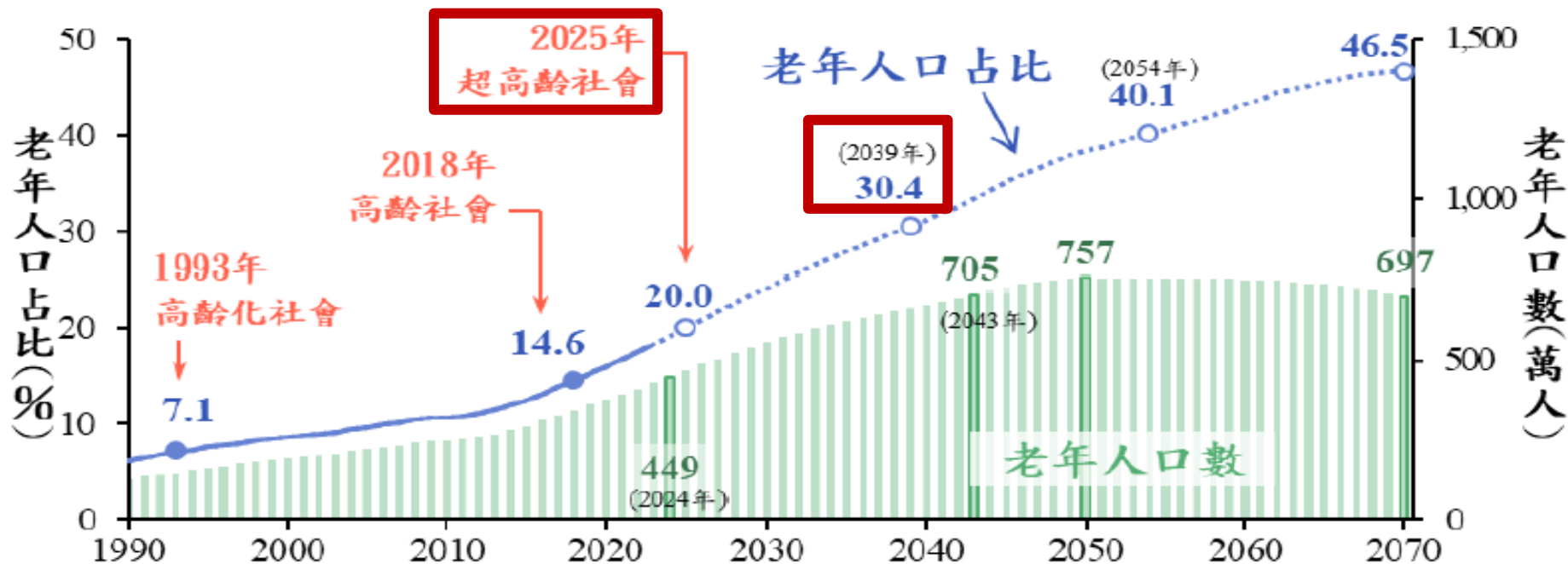
3

智慧醫療 接軌國際

4

健康台灣 生技起飛

2025 實質邁入超高齡社會

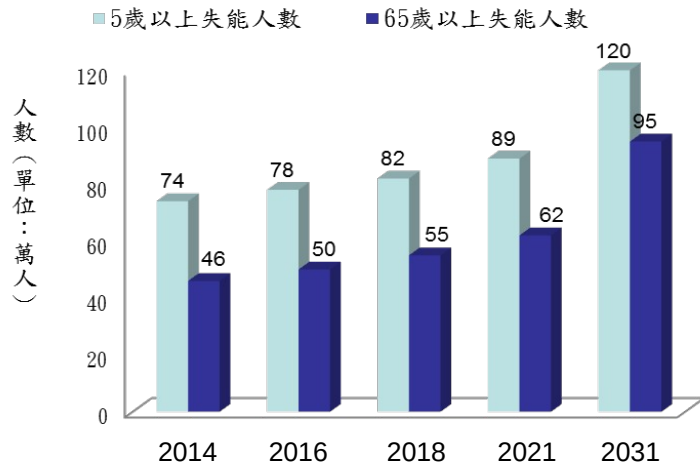
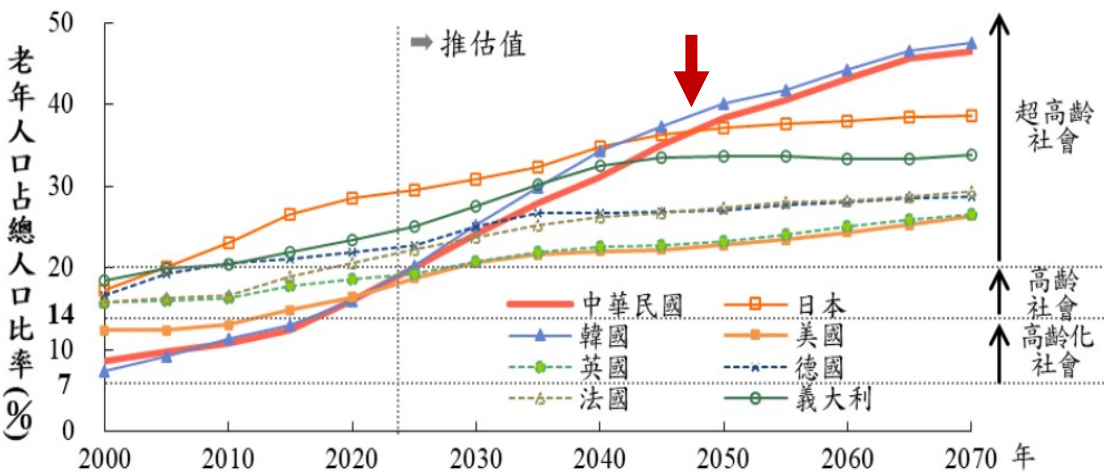


資料來源：2023年(含)以前實際值為內政部；2024年(含)以後推估值為國家發展委員會「中華民國人口推估(2024年至2070年)」之中推估，2024年10月。

老化速度領先各國 長照人口持續增加

➤ 人口快速老化，長照人口急速成長

- 老化速度與韓國相近，較日本、歐、美各國快速
- 2021 年全人口失能人數 89 萬人，2031 年增至 120 萬人



全人口失能率	3.28%	3.45%	3.63%	3.94%	5.30%
老人失能率	16.50%	16.19%	15.91%	15.60%	16.36%

註：1. 資料來源：「中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）」之中推估，2024 年 10 月；衛生福利部國民長期照護需要調查，2010-2011 年。
2. 2022 年為各國實際值，2070 年為推估值

台灣醫療體系的挑戰

超高齡社會
老化速度遽升
在宅照護需求日增

慢性疾病負荷
癌症及三高病患
醫療保健支出增加

民眾賦能與賦權
強化自我健康管理
參與醫療決策



健保財務衝擊
新興科技發展迅速
新、癌、罕藥昂貴

人力短缺
少子女化影響
工作人口逐年下降

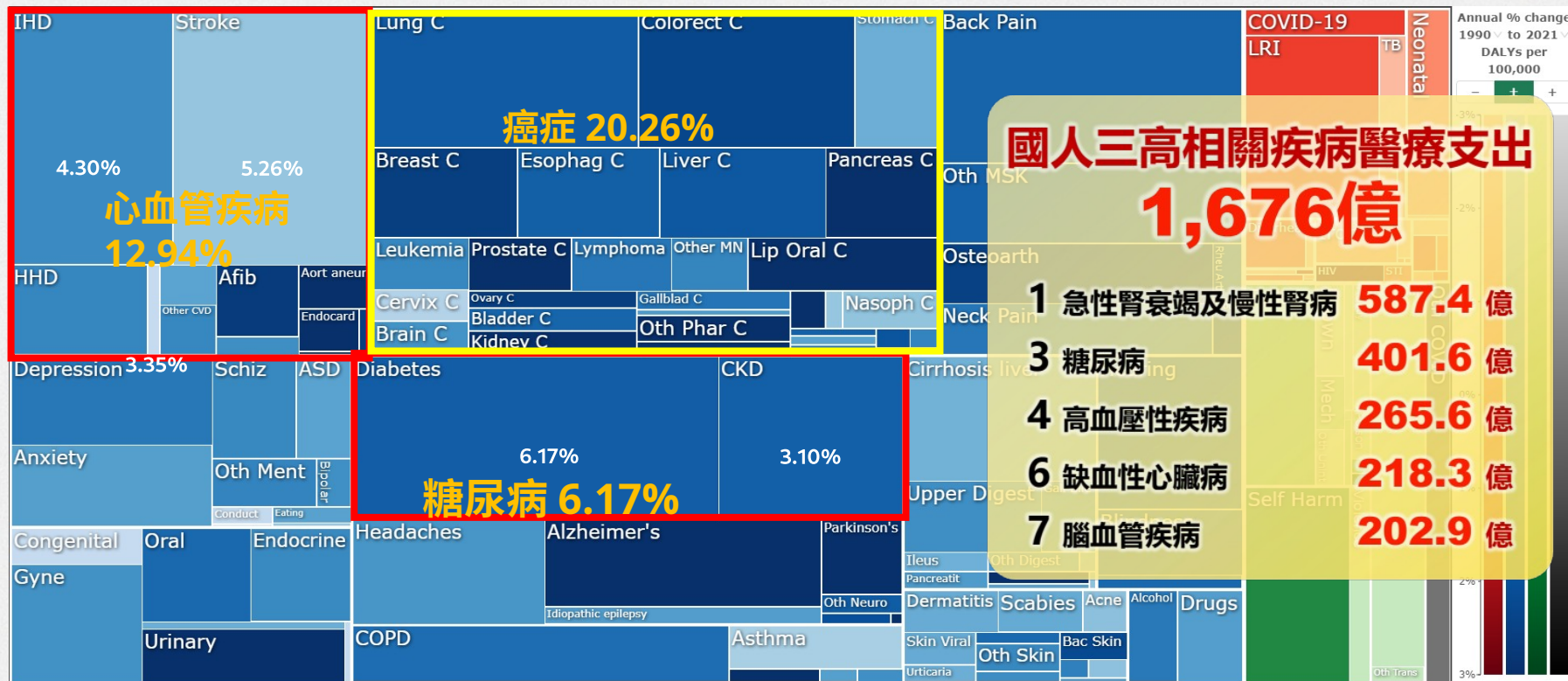
偏遠地理障礙
醫療資源分配不均
偏鄉就醫可近性低



癌症佔健保支出最高，心血管次之

癌症 20.26% 居冠，**心血管疾病 12.94%** 排第二、**糖尿病 6.17%** 第三

DALYs by Cause in Taiwan, 2021



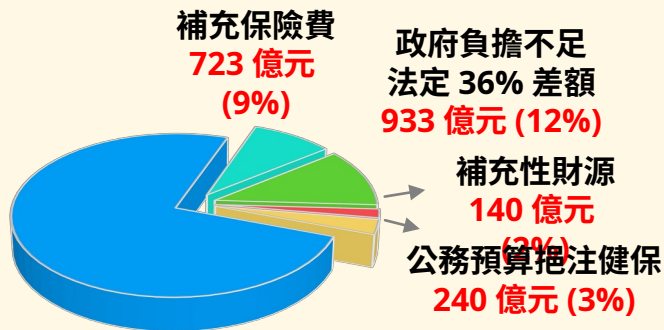
健保財務挑戰

收入面

人口高齡化少子女化 衝擊健保收入

112 年
保險收入

一般保險費
6,075 億元
(75%)



1

收入來源主要來自受薪階層
人口高齡化將加重工作人口負擔

2

補充保險費收費制度有改善空間
宜強化量能負擔公平性

3

費率調升不易，宜擴大計費基礎

支出面

藥費成長 醫療保健支出增加

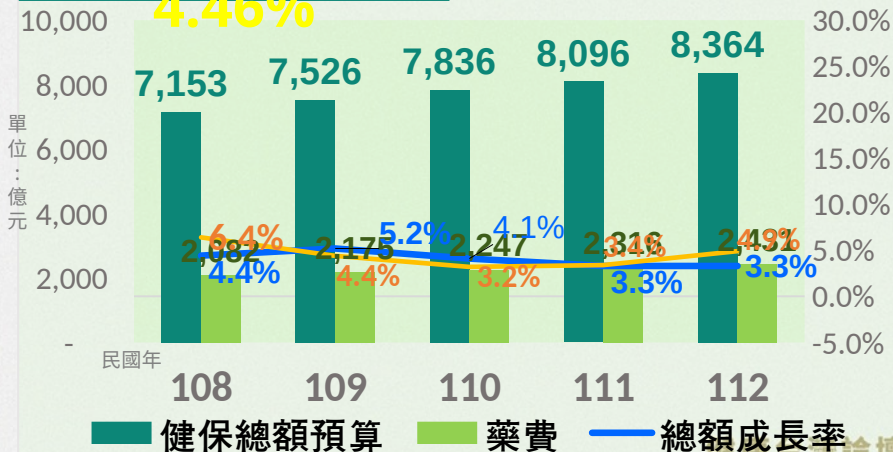
新型傳染病及疾病型態慢性化、新藥新特材持續導入、高齡社會造成就醫增加、物價上漲帶動醫療成本提升

近 5 年藥費平均成長率

4.46%

健保總額平均成長率

4.08%



註：藥費申報金額，未扣除藥品給付協議還款金額

114 年度 健保財務協助方案 (支出面)

健保總額成長
率 (高推估)

較 113 年度增加
531 億元

總額移出
以公務預
算支應

114 年度新增預算
111 億元

癌症新
藥專款

114 年度新增預算
50 億元

額外挹
注罕病
用藥專
款

114 年度新增預算
20 億元

公務預算挹注 181 億

114 年度總額成長達 **9286 億元**，較 113 年總額 (8755 億) 增加 **531 億元**，實質成長率為 6.06%；
若加計公務預算 181 億，則增加 **712 億元**，實質成長率則達 **8.13%**。

註：114 年度政府健保財務協助方案預算共達 335.6 億元

停復保制度走入歷史

「停復保」12月23日失效 健保估增24億收入

2024-11-23 01:00 聯合報／記者李青紫／台北報導



取消健保停復保制度最新說明！徐佳青邀健保署直播解惑

發稿時間：2024/12/30 16:37:13

(中央社訊息服務20241230 16:37:13)



僑委會委員長徐佳青(右)邀請健保署副署長陳亮妤(左)直播說明健保停復保規定變革

報告大綱



1

超高齡社會 健保挑戰

2

888 計畫 強化慢病

3

癌症治療 接軌國際

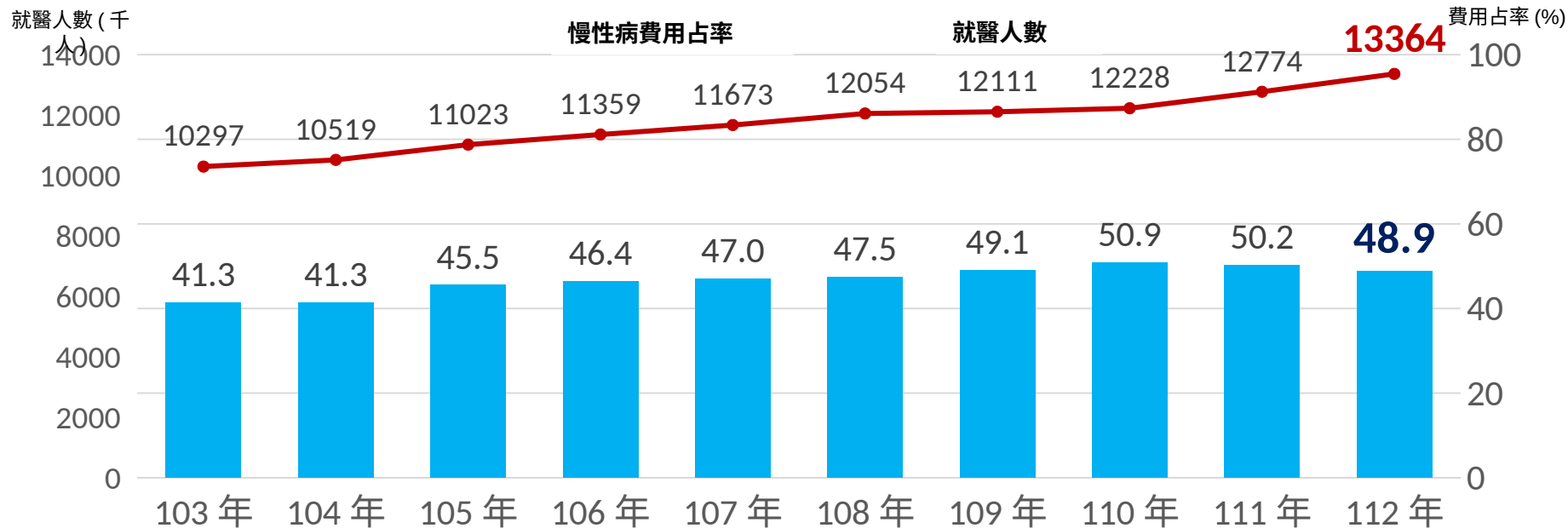
4

醫療科技 健康台灣



近十年慢性病就醫人數及費用占率

近十年慢性病就醫人數自 1,029.7 萬人 (103 年) 成長至 **1,336 萬人** (112 年)
慢性病費用占整體健保支出則自 41.3%(103 年) 成長至 **48.9%**(112 年)

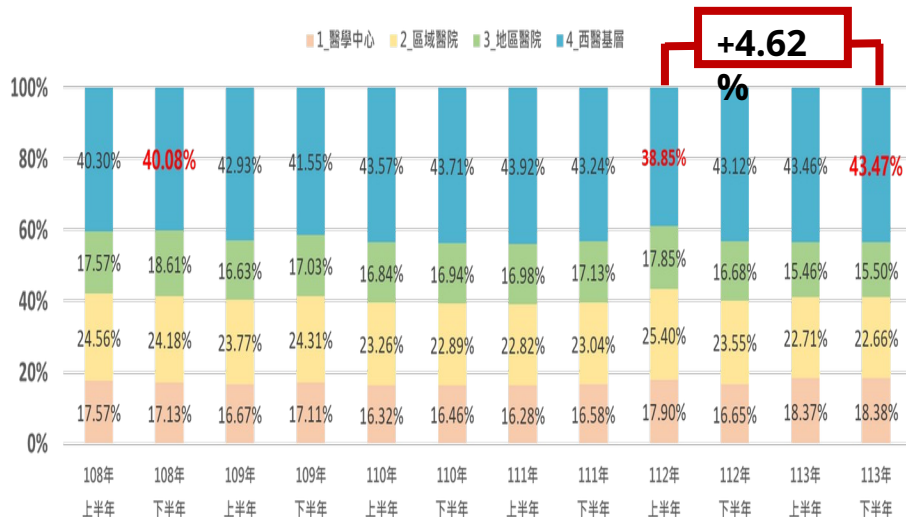


慢性病案件定義如下：

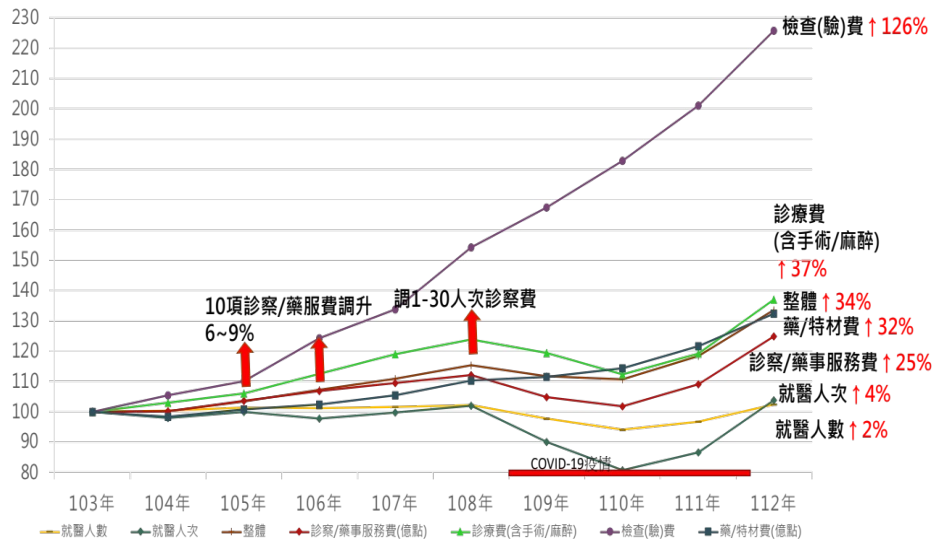
1. 門診：案件分類為慢性病 (04,24)、透析 (05)、結核病 (06)、慢箋箋調劑 (08,28)、支付制度試辦計畫 (E1)、愛滋病慢箋 (E2,E3) 或開藥天數大於 14 日。
 2. 住院：主診斷為全民健康保險醫療辦法規定得開立慢箋之「全民健康保險慢性疾病範圍」
- 排除代辦案件，且人數以 ID,BIRTHDAY 歸戶後統計

後疫情時代：慢性病流向基層醫療

113 年下半年慢性病人至西醫基層就醫件數占率，較 112 年上半年增加 **4.62%**，超過疫情前同期占率



西醫基層醫療分項費用_相較 103 年**檢查費、診療費**上升大於整體費用成長



- 資料來源：多模型健保資料平台門診、交付機構及住院明細檔。(擷取日期：114 年 2 月 3 日)
- 統計範圍：門診醫院、西醫基層總額部門(不含門診透析)案件。
- 本表排除**重大傷病**註記係申報部分負擔代碼 001、011、012、013 之案件
- 慢性病係指(原)案件類別為 04、05、06、08、E1、E2、E3 或給藥天數>14 天之案件；並排除「接受其他院所委託代(轉)檢案件且未申報費用者」、「慢性病連續處方箋調劑」、「病理中心」、「交付機構」。



糖尿病 P4P 方案 執行成效

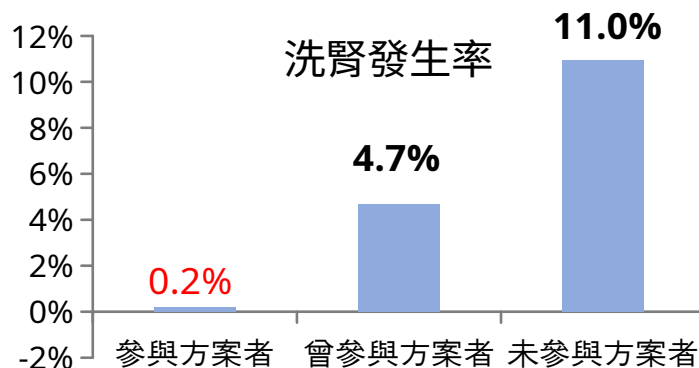
◆ 參與方案者各項檢查率皆高於未參與方案者（以 112 年為例）：

1. 參與方案者 HbA1C 之檢查率為 99.6%、未參與方案者為 35.2%。
2. 參與方案者眼底檢查之檢查率為 71.5%、未參與方案者為 11.7%。
3. 參與方案者微量白蛋白之檢查率為 92.9%、未參與方案者為 20.3%。

◆ 追蹤 94-112 年新收案：HbA1C > 9.0% 個

HbA1c >9.0% 人數	1 年後		
	HbA1c 值	人數	比率
303,016	<7%	97,499	32.18%
	7~9.0%	126,586	41.78%
	>9.0%	78,931	26.05%

◆ 參與方案者之洗腎發生率低於未參與方案者。



(中途退出)



糖尿病合併初期慢性腎臟病 (DKD) 方案

- ◆ 照護人數、參與院所及醫師數較前一年度增加
- ◆ 收案患者之檢查值良好比例較前一年度增加

項目		111 年 (開辦年)	112 年
照護人數		84,200	181,701 
參與院所數		536	805 
參與醫師數		1,330	2,268 
品質 監測 指標	UACR 控制良好率 (<30mg/gm)	51.9%	55.0% 
	HbA1C 控制良率 (<7.0% 或八十歲 以上病人 HbA1c<8.0%)	62.1%	63.6% 
	LDL 良率 (<100mg/dl)	82.3%	86.3% 

資料來源：健保資料庫 統計範圍：當年度本方案收案之對象



糖尿病共病嚴重分數 (DCSI) 概述

1. 累積性指數：

1. DCSI 是一個以診斷資訊為主的**累積型分數**，基於糖尿病患者的**併發症情況**來評估其病情的嚴重度。
2. 一旦某個併發症被診斷並計入分數，並隨病程進展而不會減少。

2. 七大共病系統：

分數基於七大併發症診斷進行計算，包括：

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. 視網膜病變 (0/1/2) | 2. 腦血管病變 (0/1/2) |
| 3. 腎臟病變 (0/1/2) | 4. 神經病變 (0/1) |
| 5. 心血管病變 (0/1/2) | 6. 周邊血管病變 (0/1/2) |
| 7. 其他代謝病變 (糖尿病酮症酸中毒、低血糖昏迷等, 0/1/2) | |

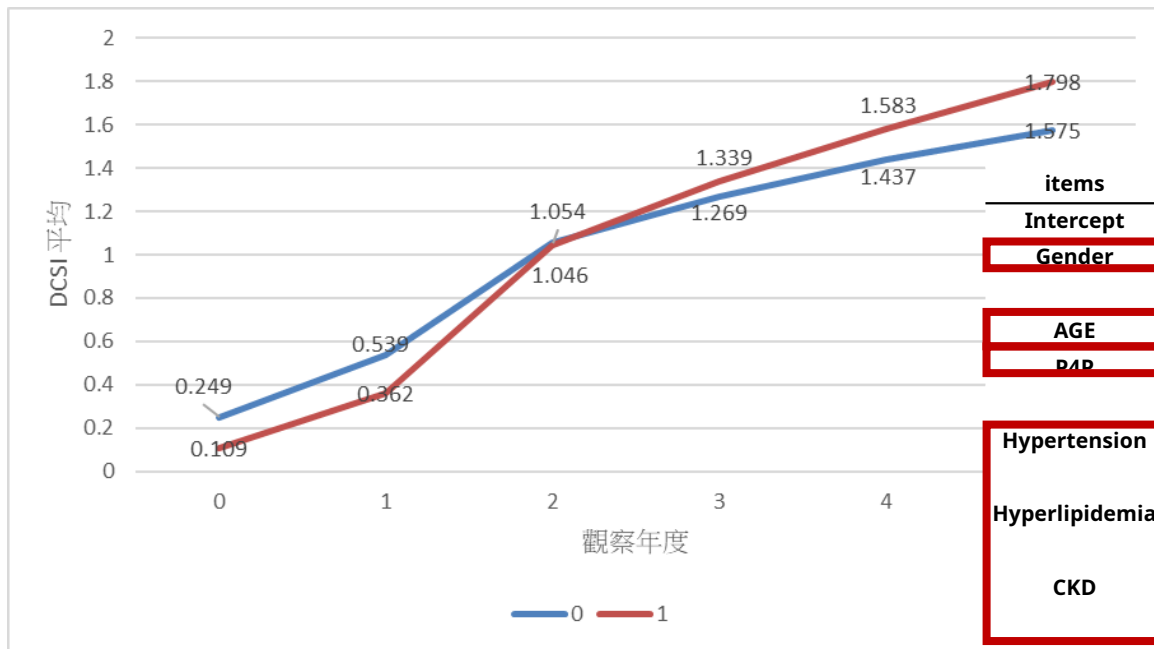
3. 不可逆特徵：

糖尿病併發症大多為**不可逆**，相關的分數通常不會下降，只會隨時間增加，反映病情的惡化。

4. 非移動觀察區間：

應持續累計患者的併發症，並基於完整的病史進行評分，而不是根據某一固定觀察期進行重新計算，避免分數的上下波動。

歷年 DCSI 計分觀察



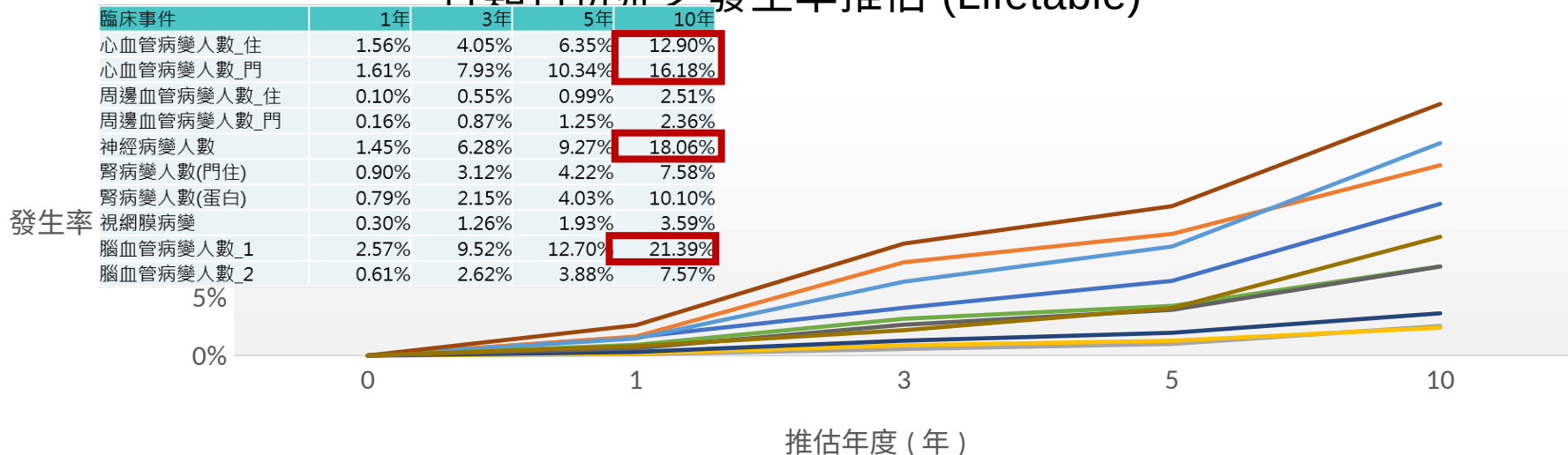
items	Coef.	St.dev.	Z	Pr
Intercept	-0.9915	0.0028	-357.96	<.0001
Gender Female	-0.0452	0.0011	-41.32	<.0001
Male(ref)				
AGE	0.0124	0	283.1	<.0001
B4P Yes	0.0663	0.0011	59.86	<.0001
No(ref)				
Hypertension Yes	0.2582	0.0012	224.53	<.0001
No(ref)				
Hyperlipidemia Yes	0.0155	0.0013	12	<.0001
No(ref)				
CKD Yes	0.8538	0.0015	560.19	<.0001
No(ref)				
FollowYr.	0.3017	0.0002	1474.29	<.0001

針對糖尿病患者初次診斷 (新發生) 前一年就醫資訊計算其 DCSI 為其基期嚴重度 (0)，以此每年累計其 DCSI 值 (1-5 年)，故可以觀察到糖尿病患罹病後嚴重度為持續增加；上表為觀察族群基期年 -5 年歷年 DCSI 平均值之趨勢表。

以廣義線性模型 (GEEmodelwithAR-1structure) 觀察 DCSI 的模型，如年齡為例，就本資料觀察年齡越大，每歲 DCSI 平均會增加 0.0124 分。

臨床事件觀察發生率推估

各類合併症之發生率推估 (Lifetable)



- 心血管病變人數_住
- 心血管病變人數_門
- 周邊血管病變人數_住
- 周邊血管病變人數_門
- 神經病變人數
- 腎病變人數 (門住)
- 視網膜病變
- 腦血管病變人數_1
- 腦血管病變人數_2
- 腎病變人數 (蛋白)



健康台灣 / 希望工程 - 三高防治 888 計畫



2024 賴清德
國家希望工程
National Project of Hope

123

通過健康憲章

45

健康台灣深耕計畫

8 年 888 計畫

改善醫療人員工作環境，
強化醫事人力增補

確保健保永續經營

678

擴大心理健康支持

9

強化「國家癌症防治計畫」

強化原住民族健康服務

智慧醫療結合健康照護，
推動生醫產業

10

長照3.0

健康台灣論壇

打造台灣成為健康幸福的國家

123

改善醫療人員工作環境

45

增加心理健康支持

培養國人營養及愛好運動習慣

8 年 888 計畫

提供重要癌症篩檢率

678

百億癌症新藥基金

9

多元財務管道增加健保總額

加速智慧醫療與健康照護結合

檢討公醫薪資結構

10

長照 3.0

8 年 888 計畫政策目標

- (一) 80% 三高、心腦血管疾病、CKD 病人加入共照網
- (二) 80% 共照網病人，接受生活習慣諮商
- (三) 80% 共照網病人，達到三高控制

**延緩慢病惡化、失能
提升國人健康餘命**



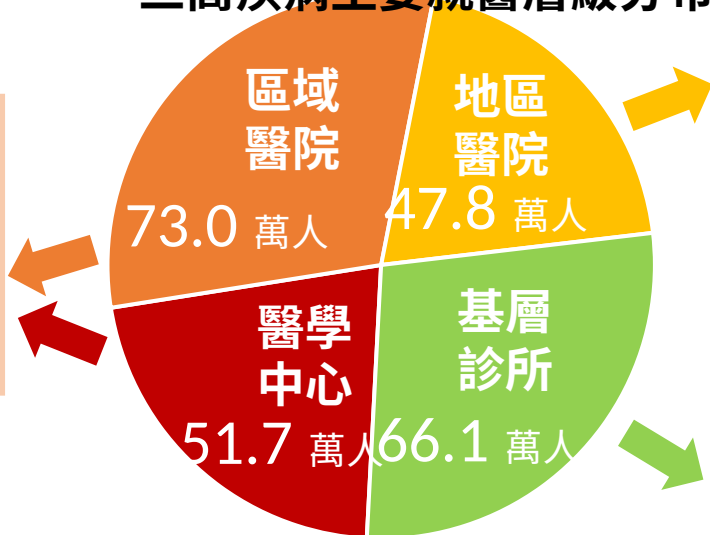


大家醫平台 - 擴大服務涵蓋率

112 年約 534 萬名三高患者，**113 年已有 315 萬人 (59%)** 已接受家醫計畫、代謝症候群防治計畫、P4P-DM/CKD/DKD、全人全社區照護計畫相關照護

未參與任一計畫對象中 (233 萬人) 之
三高疾病主要就醫層級分布

公私協力、接軌國際，透過 AI 疾病嚴重度分級，疾病嚴重度高者，由區域級以上醫院收案



113 年辦理**地區醫院全人全社區照護計畫**，逐步將三高疾病高風險族群納入照護
(113 年收案 8.5 萬人)

交由家醫計畫收案，
並推行**家醫計畫 2.0**



導入生活習慣諮商，有效控制慢性疾病病程發展

生活型態醫學

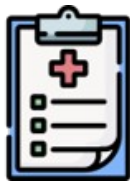
使用實證有效的生活型態，包括營養、運動、睡眠、壓力管理、避免使用高危害性物質、正向社會連結，由接受過訓練的臨床醫師提供介入，以預防、治療，並逆轉慢性疾病。



Making the Case for Lifestyle Medicine
Susan Benigas, BS; Dexter Shurney, MD, MBA, MPH, FACLM,
DipABLM; Ron Stout, MD, MPH, FACLM, FAAFP
doi:10.12788/jfp.0296

健康台灣 - 三高防治 888 政策，規劃將**生活習慣諮商**導入**全人全社區照護計畫**及**家醫計畫**，藉由醫療團隊介入，改變病人生活方式，有效控制慢性疾病病程發展

Step 1：病人個人健康資料建檔



- ✓ 參採生活型態醫學會 - 生活型態評估量表，**收載生活型態醫學的各領域評分**，以協助醫師後續進行生活習慣諮商及訂定計畫

Step 2：提供生活習慣諮商



- ✓ 與國健署、學協會共同**研議生活習慣諮商推動計畫**，**規劃導入 114 年家醫計畫及全人全社區照護計畫**

生活習慣諮商改善長者安眠藥使用

提升全人全社區照護 健保署：生活諮商指標明年上路

2024-12-08 20:43 聯合報／記者沈能元／台北即時報導

+ 失眠



陳亮妤指出，分析安眠藥用藥情況，各年齡層用藥量均上升，六十五歲至九十歲為主要用藥族群，去年六十五至六十九歲使用安眠藥人數高達廿四萬人，其次為六十至六十四歲廿三點一萬人、七十至七十四歲廿二點一萬人。

開立安眠藥科的醫療科別，以精神科為主，其次為家醫、內科、心臟血管內科及神經科。

陳亮妤表示，許多三高患者合併慢性失眠，希望透過「生活習慣諮商」，病人能透過衛教指導，由醫師填寫病人生活習慣評估量表，以期健康生活正、降低多重用藥。

報告大綱

1

超高齡社會 健保挑戰

2

888 計畫 強化慢病

3

智慧醫療 接軌國際

4

健康台灣 生技起飛

設立醫療科技評估之專責辦公室



CHPTA 專責辦公室

Center for Health Policy and Technology Assessment (CHPTA)

健康政策與醫療科技評估中心

112 年 12 月 27

揭牌啟動典禮

113 年 1 月 1 日

成立專責辦公室

✓ 使命：

- 1) 強化藥品給付審查及平行送審機制。
- 2) 協助暫時性支付之推動規劃。
- 3) 推動行政法人設置規劃。

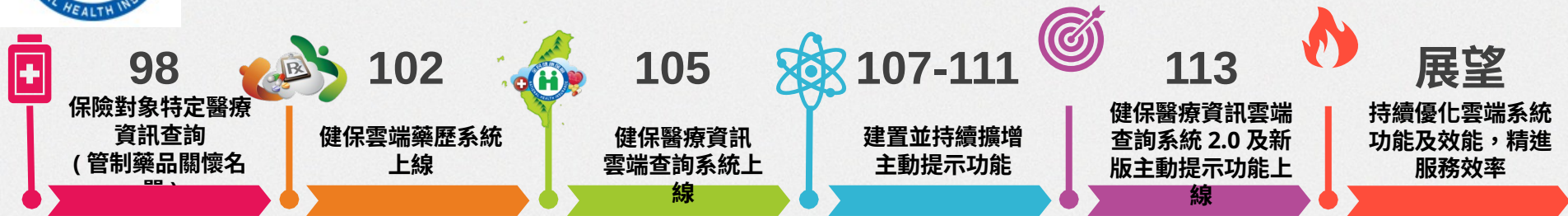
✓ 任務：

- 1) 辦理醫療科技評估 (HS、HTA 及 HTR)。
- 2) 新醫療技術、藥品及醫材給付審查。
- 3) 藥物經濟學評估。
- 4) 法規研析及政策評估。
- 5) 人才培訓與國際合作。





強化健保大數據結合資訊科技



健保特約院所



HIS

多元認證
健保 VPN



輔助診療

醫療服務

健保醫療資訊
雲端查詢系統

2.0

113.4.17 上線



- 過敏藥物
- 藥品交互作用
- 潛在 C 肝病人追蹤
- NSAIDs 用藥及腎功能

新版 113.6.17 上線

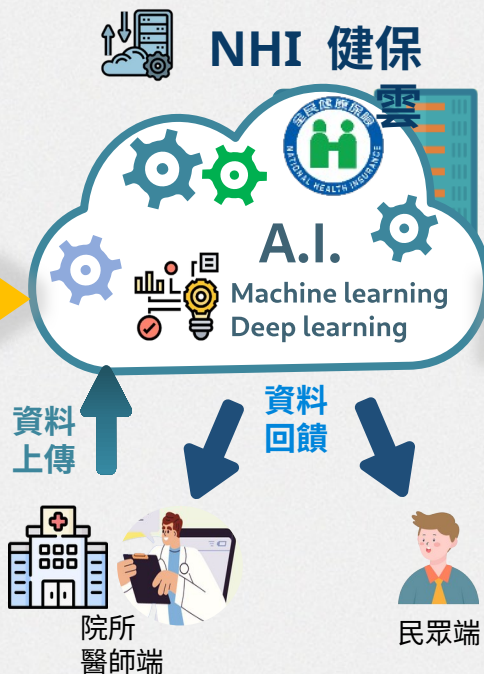
運用大數據 疾病分級分流

透過公私協力，逐步**建構疾病風險分級 (糖尿病、ASCVD)**及預測模型開發，導入**大家醫平台**，以創新模式建構以民眾為中心的整合式全人全程健康照護

數據輸入 健保資料庫

- ☑ 性別
- ☑ 年齡
- ☑ 共病
- ☑ 家族病史
- ☑ 社經資訊
- ☑ 風險因子
- ☑ 檢查檢驗數據
- ☑ 穿戴式裝置或自行上傳資訊等

- ☑ ICD-10 Code
- ☑ (aDCSI 7 大類合併症 /52 個亞型)



數據輸出 預測結果

罹病前

未來發生糖尿病之風險預估

- 1) 10 年內
- 2) 5 年內
- 3) 1~3 年內

罹病後

糖尿病合併症分級 (分 6 等級)

導入後關鍵指標

- 1) 總住院率
- 2) 特定原因住院率
- 3) 死亡率
- 4) 慢性病罹病率
- 5) 醫療費用

家醫大平台 依風險**分流照護** 分級獎勵

分 6 等級

- 綠色：低風險
- 黃綠色：有風險
- 黃色：中風險
- 黃橙色：中高風險
- 紅橙色：高風險
- 紅色：嚴重風險

分流照護

門診、衛生所

地區醫院

區域醫院

醫學中心



推動基層院所 HIS 雲端數位轉型

- ▶ 數產署與本署合作於 113 年推動「診所雲端系統研發計畫」
- ▶ 本署將持續擴大基層院所完成 HIS 系統雲端轉型，**規劃 114 年起推動補助計畫**

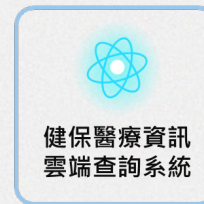
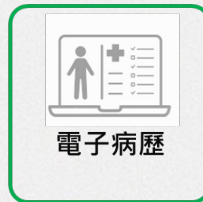
計畫名稱 基層院所醫療資訊系統 (HIS) 雲端轉型補助計畫

執行期間 114 年起

補助方式 依轉型方案及轉型家數給予**資服廠商**補助費用

推動家數 114 年以**西醫為主**，中醫 / 牙醫 / 藥局為次

雲端轉型功能項目



本署重要政策功能

開放偏鄉離島遠距醫療 - 強化健康平權

遠距醫療給付計畫

◆ 執行現況：

- **醫師對醫師 (B2B) 遠距會診模式**
在地院所醫師親自診察病人，遠距院所專科醫師透過視訊給予診療建議，共同合作照護
- 截至 113 年 11 月，已提供 59 個鄉鎮及 11 個急重症轉診網絡遠距會診服務共 121 家在地院所與 50 家遠距院所，服務總人次約 14,603 人次。

項目			111年	112年	113年 1-11月
專科門 診遠距 會診	論服 務量	服務人數	1,881	2,851	3,748
		服務人次	3,446	4,958	6,811
	論診 次	開診數	637	624	651
		服務人次	2,845	3,034	5,100
急診遠距會診		服務人數	85	844	2,643
		服務人次	85	858	2,692

◆ 113 年新增：

為提升山地離島偏僻地區民眾之專科門診可近性，配合通訊診療治療辦法至 113 年 7 月 1 日實施，遠距醫療給付計畫自同年 8 月 27 日起，擴大適用醫療資源缺乏地區及矯正機關。

專科門診遠距會診

眼科、耳鼻喉科、皮膚科、心臟內科、胃腸科、神經內科、胸腔科、精神科 (限矯正機關)



視訊診療
未來規劃



急診會診



醫師
(急診)



醫師
(遠距
會診)

研議加寬開放適用「遠距醫療給付計畫」地區及科別，擴大保障民眾就醫權益。

打造就醫全流程數位化 破除空間限制

目標

- ▶ 推動雲端病歷與虛擬健保卡、電子處方箋，將有利於遠距、居家、偏鄉、行動醫療等服務。
- ▶ 數位身分認證機制，提供民眾更便利的就醫方式，邁向數位醫療照護服務新時代

申請虛擬健保卡

線上申請
逐案審核



身分證正面 清晰大頭照

就醫

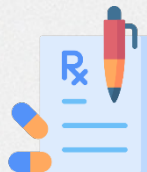
功能強化



透過授權同意進行
掛號、看診、檢查、
領藥等就醫程序

交付處方

電子處方箋
結合數位簽章



實體處方箋交付
實體調劑
或配合藥師送藥服務

繳費

介接
院所線上支付



合作行動支付
醫指付、街口支付
及阿佩 (APAY) 支付



視訊看診 X 雲端 HIS X 線上刷卡支付

報告大綱

1

超高齡社會 健保挑戰

2

888 計畫 強化慢病

3

智慧醫療 接軌國際

4

健康台灣 生技起飛

健康資料法規強化

- ▶ 「全民健康保險資料管理條例」草案，經立法院衛環委員會 2025 年 6 月 26 日審查完竣，交付黨團協商
- ▶ 研擬過渡法規「全民健康保險資料研究利用與停止利用申請作業及管理要點」於 8 月 12 日施行

研究利用範圍及種類

□ 申請者

政府機關（構）、行政法人、醫療機構、學術研究機構、大學及受政府機關委託之大學、法人、機構

□ 資料種類

1. 承保資料（投保身分、地點、薪資級距及其他投保資料）
2. 醫療服務資料（保險對象就醫與用藥紀錄、醫學影像、病理報告、檢查與檢驗結果、重大傷病狀態及其他醫療服務申報資料）

預期效益

保護人民資訊隱私權前提下，推動資料合理利用，充分發揮資料價值，促進學術與科技研究發展。

申請停止利用

主動提出



紙本 / 數位



倉儲收載

退出名單轉入倉儲主機收載



系統排除

申請使用健保資料時排除申請民眾資料



定期評估

定期評估退出民眾對資料代表性衝擊



- 說明提供利用對公衛、醫療發展及研究助益
- 書面（臨櫃）/ 數位（健保快易通 APP）申請
- 效力不溯及既往（已申請利用不受影響）

建構家醫大平台串聯全人照護

院所端 - 家醫大平台



大家醫平台使用家數約 4,900 家診所

視覺化呈現介面

整合大數據，訂製個人化治療，提升健康管理效率

民眾端 - 健康存摺



智慧生成衛教報告

Understanding Your Risk: 衛教報告系統，根據您的資料，您有第二型糖尿病、目前血糖值(HbA1c)偏高、飲食與生活、此外，您有高血壓(HDL)和慢性腎臟病(CKD)的風險。您的糖尿病風險指標 (dm) 為 1.579。RAAG32、表示您需要繼續控制血糖和相關風險。您的主要風險因素可能包括您的飲食、特別是高糖和脂肪的飲食、身體活動量、您有神經病變的風險較高 (生活年齡較高)、心血管疾病的風險也較高 (根據心血管系統與生活年齡和 BMI、體重和 BMI)。

Diet & Nutrition: 飲食方面，控制血糖是首要任務。建議您認識營養師，制定個人的飲食計畫。總體來說，您應該選擇低升糖指數(GI)的食物，控制碳水化合物和脂肪的攝取量，並增加纖維素的攝取，避免高糖和加工食品。

Recommendations:

1. 選擇全穀類食物、水果、蔬菜、全蛋、低脂乳製品、代乳品和蛋白質。

賦能民眾，提升自我健康管理，強化醫病溝通

AI 疾病風險分級



廠商端 - 數位工具

全民健康保險數位照護獎勵計畫

- ✓ 開發廠商蒐集民眾的健康數據紀錄分析及監測，提供個人化衛教資訊。
- ✓ 取得民眾授權同意，將健康數據彙整至家醫大平台。

2025 年審核通過廠商名單		
廠商名稱	APP	執行日期
智齡科技股份有限公司	Jubo 健康好食運	2025 年 1 月 1 日起
慧康數位醫療器材有限公司	智抗糖	
吉樂健康資訊科技股份有限公司	WaCare	2025 年 4 月 1 日起
遠傳電信股份有限公司	Health 健康	
永悅健康股份有限公司	H2U pano	

導入數位工具，優化慢性病管理模式

建構智慧化在宅醫療生態系

► 2024 年 7 月 1 日起實施「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫 (ACAH)」，截至 2025 年 6 月底成果：

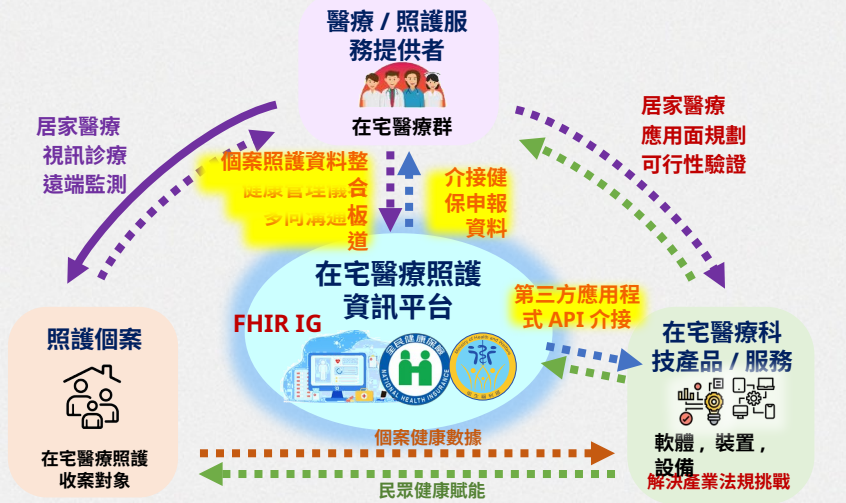
- 參與院所：共 175 個團隊、801 家院所 (33% 院所提供通訊診療)
- 收案對象：共照護 3,398 人次
8.7 成民眾可在家 (照護機構) 完成治療
- 照護天數：平均照護天數約 6.9 天 (傳統住院 11-15 天)



平均照護天數	
肺炎	8 天
尿路感染	6.3 天
軟組織感染	6.3 天

► 預計 2026 年建置「在宅醫療照護資訊平台」
經費 2.5 億元 / 年，四年共 10 億元 (2025 年 6 月核定)

- 跨單位合作：
- 健保署建置平台
 - 資訊處制定 FHIR IG
 - 國衛院進行在宅服務網絡應用、驗證與優化
 - 醫藥品查驗中心提供產品法規諮詢，增加產業能量



健康台灣 驅動數位照護



1 家醫大平台 串聯全人照護

- ▶ 數位化追蹤，回饋整合性資訊，協助醫師制定個人化治療計畫，提升健康管理效率。2025 年 6 月約 **4,900 家診所** 使用平台。
- ▶ 導入 AI 疾病風險預測模型，提供個人化衛教資訊。



2 健康存摺 強化自主健康管理

- ▶ 結合 Google, Apple, Garmin 載入生理量測資料
- ▶ 健康存摺使用人數約 **1,212 萬人**，使用人次 5.1 億次。
- ▶ 資料介接服務 SDK 串聯第三方服務，**23 支 App** 介接。



3 健保醫療資訊雲端查詢系統

- ▶ 114 年 5 月推出雲端 2.0，優化系統介面與資訊呈現，強化醫療照護品質及病人安全。
- ▶ 114 年 1 月至 6 月共有 **2 萬 9,055 家院所**、**9 萬 8,084 位** 醫事人員查詢使用本系統，醫療院所整體使用率達 **96.0%**。



4 全民健康保險數位照護獎勵計畫

- ▶ 搭配 **大家醫平台** 之規劃導入數位工具，讓院所透過創新的慢性病管理模式，以達延緩慢性病發生或惡化之目標。
- ▶ 本計畫截至 114 年 6 月份，已有 **5 家** 數位工具開發廠商審核通過。



5 癌症治療 數位轉型

- ▶ 以 **FHIR** 格式交換 NGS 檢測申報資料收載：實作 **9 家**
- ▶ 癌症重大傷病申請：實作 **38 家**
- ▶ 癌藥事前審查申請：實作 **49 家**、上線 **5 家** (中榮、馬偕、林長、高醫、中山附醫)



6 整合全國性醫療費用資訊平台

- ▶ 院所、22 縣市衛生局、藥商 / 特材商共用平台，簡化程序，加速核定，資訊公開透明，2025 年 **5 月起試行**。
- ▶ 開放民眾查詢、院所 / 藥材商申請，啟動聯合審查。



7 電子處方箋 完善數位就醫流程

- ▶ 2024 年 9 月花蓮院所與藥局試行，2025 年 7 月起 **六分區** 擇點推動，截至 7 月共 **44 家醫療院所** 上傳電子處方箋。
- ▶ 預估全國 **每日約 100 萬張** 處方箋，減碳 1 年達 **73 棟 101** 大樓。



8 推動基層醫療院所數位轉型

- ▶ 2025 年 2 月起以計畫補助資訊服務廠商，協助基層院所將地端醫療作業系統 (HIS) 移轉到雲端服務環境。
- ▶ 核定 **16 家廠商**，預計導入 **830 家院所** (含中、西、牙醫診所及藥局)。

WHA 國際記者會的驚喜



友邦來自國內醫護的耕耘



智慧醫療健保論壇 (WHA)



健康台灣 健保改革藍圖

1. 優化健保財務

- ▶ 擴大政府責任及財源
- ▶ 改革補充保費
- ▶ 研議**健保協同商保**

2. 強化慢病照護

- ▶ 推動**大家醫計畫**，落實 **888 慢性病照護目標**。
- ▶ 檢討健保**居家醫療計畫**，無縫銜接長照服務。

3. 普及醫療服務

- ▶ 持續擴大偏遠地區**遠距醫療服務**。
- ▶ 逐步推廣偏鄉**全人全家全社區照護計畫**。
- ▶ 搭配醫療網，保障**燈塔型醫院營運**，維持各專科服務量能。

4. 改革藥品政策

- ▶ 檢討健保 **DET 政策**，強化藥品供應韌性。
- ▶ 加速**新藥、新科技**導入健保體系。
- ▶ 成立**行政法人國家醫療科技評估中心**，以實證基礎 (HTR)，檢討藥品及特材給付。

5. 精準癌症防治

- ▶ 落實**精準癌症防治三箭**，精進國家癌症防治計畫。
- ▶ 建構**精準健康生態系**。

6. 醫療數位升級

- ▶ 推動健康平權**健保數位升級計畫**。
- ▶ 公私協力**營造智慧雲端服務**。

23年來首見！健保總額協商四部門一致通過 醫界點出三大關鍵因素

2025-09-25 09:23 聯合報／記者沈能元／台北即時報導



Health for All

